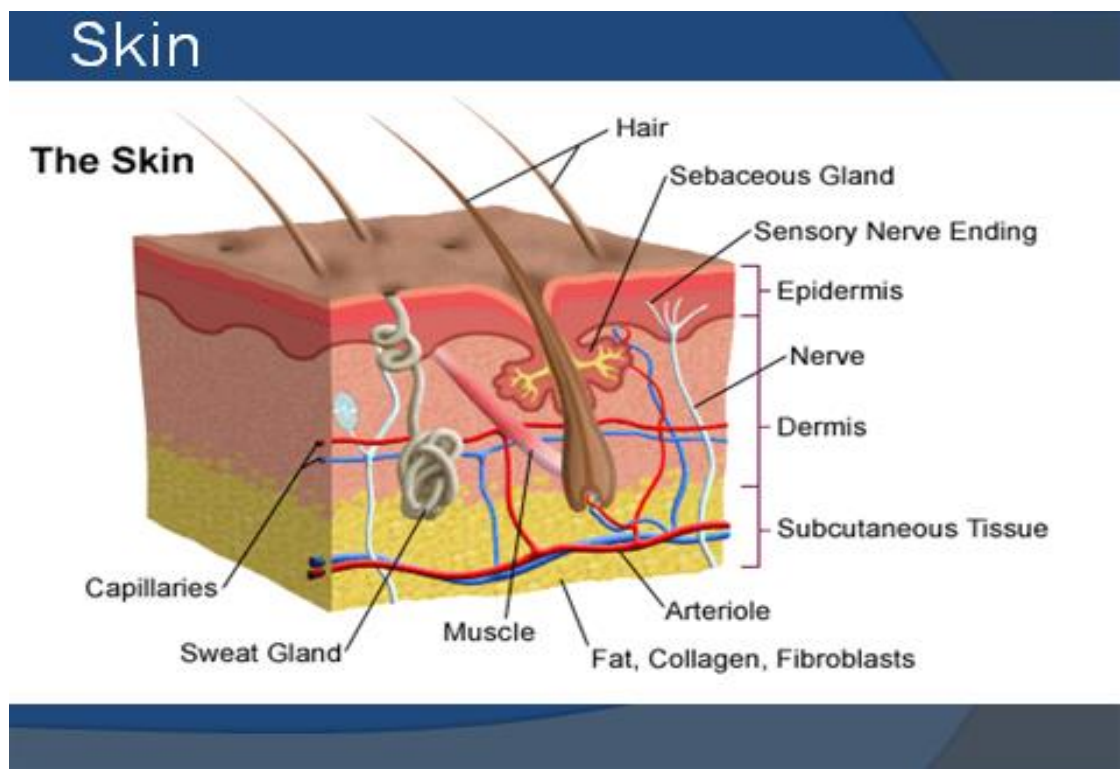


Assessment of skin, hair, and nails

تقييم البشرة والشعر والأظافر

The skin: is the **largest organ of the body**. Every square inch of skin contains thousands of cells and hundreds of sweat glands, oil glands, nerve endings, and blood vessels. When we look at another person, we are in fact looking at their skin. As our skin represents our outward appearance to the world, unsightly blemishes or lesions can have a significant impact on a person's self-esteem, despite their small size.

الجلد: هو أكبر عضو في الجسم. يحتوي كل بوصة مربعة من الجلد على آلاف من الخلايا ومئات الغدد العرقية، والغدد الدهنية، والنهيات العصبية، والأوعية الدموية. عندما ننظر إلى شخص آخر، فإننا في الواقع ننظر إلى بشرته. فبشرتنا تمثل المظهر الخارجي أمام العالم، العيوب القبيحة أو الآفات قد تكون لها تأثير كبير على احترام الشخص لذاته، رغم صغر حجمهم.



Skin components:

مكونات البشرة:

The skin is the largest organ in the body and consists of skin, hair, nails and glands. The skin is the organ that covers the human body.

الجلد هو أكبر عضو في الجسم ويتكون من الجلد والشعر والأظافر والغدد. الجلد هو العضو الذي يغطي جسم الإنسان.

The major purposes of skin:

الأغراض الرئيسية للجلد:

- 1- Prevents dry body, excessive water loss.
1- يمنع جفاف الجسم وفقدان الماء الزائد.
- 2- Regulates body temperature.
2- ينظم درجة حرارة الجسم.
- 3- Is a major obstacle to infection in the body.
3- يعتبر عتبة كبيرة أمام العدوى في الجسم.
- 4- Protect the underlying tissue of the body.
4- حماية الأنسجة الأساسية للجسم.

- 5- The skin acts as a barrier against the entry of bacteria and chemicals into the body.
 5- تعمل البشرة كحاجز ضد دخول البكتيريا والمواد الكيميائية إلى الجسم.
- 6- The skin contains nerve endings and special receptors that provide sensory perception of environmental stimuli. These nerve endings send information to the brain such as those associated with pain, temperature, cold, touch, pressure and vibration.
 6- تحتوي البشرة على نهايات عصبية ومستقبلات خاصة توفر الإحساس الحسي من التحفيزات البيئية. هذه النهايات العصبية ترسل معلومات إلى الدماغ مثل تلك المرتبطة بالألم والحرارة والبرودة واللمس والضغط والاهتزاز.
- 7- The skin controls the regulation of heat by its ability to respond to changes in internal and external temperature by narrowing and expanding the vessels.
 7- تحكم البشرة في تنظيم الحرارة من خلال قدرتها على الاستجابة للتغيرات الداخلية والحرارة الخارجية عن طريق تضيق وتوسع الأوعية الدموية.
- 8- The self-composition of vitamin D, which is vital to the metabolism of calcium and phosphorus, occurs in the skin.
 8- التكوين الذاتي لفيتامين د، الذي يعتبر حيويًا لعملية استقلاب الكالسيوم والفوسفور، يحدث في الجلد.

طبقات الجلد:: Layers of the skin

The skin is made up of **3 layers**: the epidermis, dermis, and the subcutaneous tissue.
 الجلد مكون من 3 طبقات: البشرة، الأدمة، والأنسجة تحت الجلد.

1- Epidermis layer : طبقة البشرة : طبخت البشرة : 1- طبقة البشرة

It is a superficial vascular layer of the skin, consisting of an **external corneal tissue** that is dead and acts as a **protective barrier**. The thickness of these two layers is approximately **0.05 mm to 0.1 mm**. The skin is nourished by blood vessels in the dermis. The skin is replaced with new cells **every 30 days**. In the epidermis there are two types of cells; **melanocytes (5%)** and **keratinocytes (95%)**. Melanocytes are spread throughout the basal layer of the skin and secrete **melanin**, the dye that gives **color to the skin**. The hair protects the body from harmful ultraviolet (ultraviolet) rays and sunlight. And that all races have roughly the same number of melanocytes. **The difference in the color of the skin and hair is due to the amount of melanin produced.** The formation of keratinocytes (Keratinocytes) of skin cells in the basal layer, at first these cells are not distinct; as soon as they **ripen** they make their way to the outer surface of the skin where they **flatten** and die to form the outer skin layer (stratum corneum). **Keratinocytes produce keratin protein**, which is vital for skin function as a protective barrier. The upward movement of keratinocytes from the basal membrane to the corneal layer takes about 4 weeks. If the dead cells are slough off very quickly, the skin will be thin and corrosive. If new cells form faster than old cells, the skin becomes brittle and thicker. These changes in the cell cycle are the cause of many skin problems.

2. Dermis layer: طبقة الأدمة : 2. طبقة الأدمة: طبقة الدهون

Dermis is a supportive layer of **connective tissue** located under the skin layer. Their thickness varies from 1 mm to 4 mm. There are many blood vessels that help regulate body temperature and blood pressure. The bulk of the dermis is made up of **collagen**, which is responsible for giving the mechanical strength of the skin. In the

dermis layer are elastin fibers, nerves, lymphatic vessels, hair follicles, sebaceous and sweet glands.
طبقة الأدمة تحتوي على الياف الإيلاستين، الأعصاب، الأوعية اللمفاوية، بصيلات الشعر، والغدد الدهنية و غدد حلوة.

3. Hypodermis layer (subcutaneous tissue) (الأنسجة تحت الجلد): طبقة اللحم (الصقت حجج الجلد)

The subcutaneous tissue layer is not actually part of the skin. It binds the dermis to underlying structures. It is composed primarily of loose connective tissue and adipose (fat) tissue interlaced with blood vessels. The subcutaneous layer stores fats, insulates and cushions the body, and regulates temperature. The amount of fat in the subcutaneous layer varies with the region of the body and sex, age, and nutritional state.
طبقة النسيج تحت الجلد ليست في الواقع جزءا من الجلد. إنها تربط الأدمة إلى الهياكل الأساسية. وهو يتكون أساسا من نسيج ضام رخو و النسيج الدهني (الدهون) متشابك مع الأوعية الدموية. الطبقة تحت الجلد تخزن الدهون، يعمل على عزل الجسم وتخفيف الصدمات، وينظم درجة الحرارة. كمية الدهون في الطبقة تحت الجلد تختلف حسب منطقة الجسم والجنس والعمر والتغذية دولة.

ملحقات البشرة الجلدية: Epidermal appendages

1. Hair

الشعر

2. Nails

الأظافر

3. Sebaceous

دهني

4. Apocrine

الغدد الأبوكرينية

5. Eccrine

الغدد العرقية الإكرينية

- ✓ The hair and nails are made of **keratin**, which hardens to be hair and nails.
الشعر والأظافر مصنوعة من الكيراتين، الذي يتصلب ليصبح شعرا وأظافر.
- ✓ Hair grows in most parts of the body except for the lips, the palm of the hand, the soles of the feet, nipples, and parts of the outer genitals.
ينمو الشعر في معظم أجزاء الجسم ما عدا الشفاه وكف اليد، راحة القدمين، الحلماء، وأجزاء من الأعضاء التناسلية الخارجية.
- ✓ Hair color is the result of **genetics factors** and color is determined by the **type** and **amount of melanin** in the hair shaft.
لون الشعر هو نتيجة عوامل وراثية ويتم تحديد اللون بواسطة النوع و كمية الميلانين في ساق الشعر.
- ✓ Hair grows about 1 cm per month, 50-100 hairs are lost every day, and growth rate is not affected by hair cutting.
ينمو الشعر حوالي 1 سم في الشهر، يفقد 50-100 شعرة كل يوم، ومعدل النمو لا يتأثر بقص الشعر.
- ✓ The nails grow from the **nail matrix**, which is shaped like a white **crescent** **هلال** that extends behind the folds of the nearby nail.
تنمو الأظافر من مصفوفة الظفر، التي تشبه الهلال الأبيض، ويمتد خلف طيات الظفر القريب.
- ✓ The nails grow at a rate of 1 mm per week, and the growth of the toenails is somewhat slower than the fingernails. Fingernails are usually renewed every 3 to 6 months, while the missing toenails may require 12 months or more to regenerate.
تنمو الأظافر بمعدل 1 ملم في الأسبوع، وتنمو أظافر القدم هو أبطأ قليلا من الأظافر. الأظافر عادة ما تتجدد كل 3 إلى 6 أشهر، بينما قد تتطلب أظافر القدم المفقودة 12 شهرا أو أكثر لتجديدها.

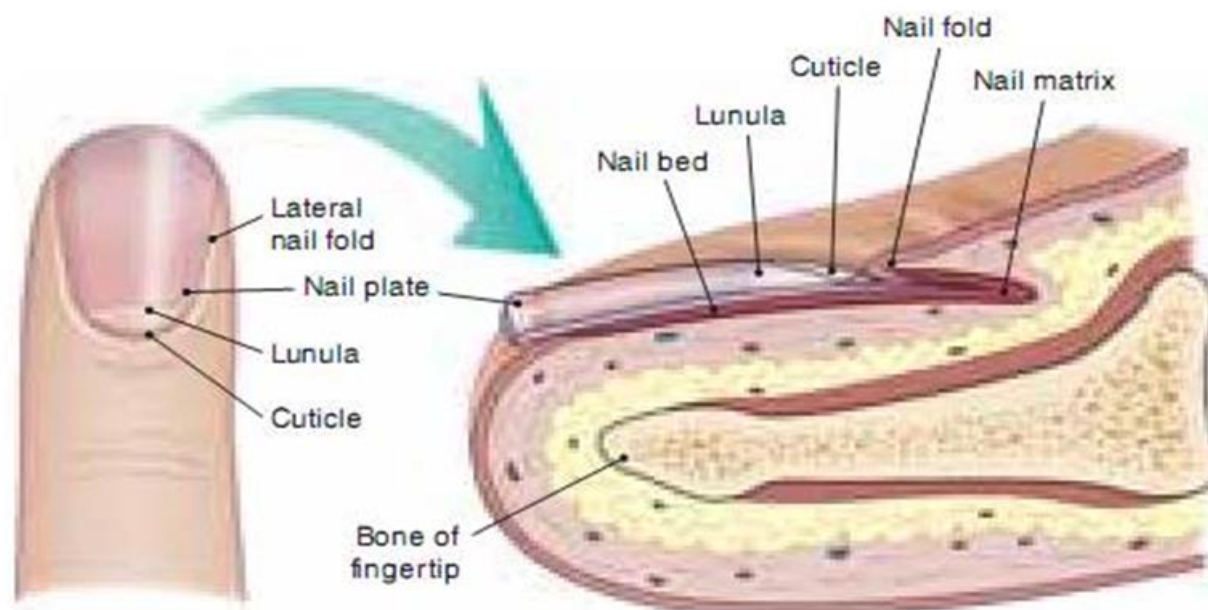


FIGURE 10.2. Structures of the nails.

Sebaceous Glands: الغدد الدهنية

- Sebaceous secret Sebum الزهم (oily secretion) a mixture of fatty acids and salts) , which is emptied into the hair shaft ^{انسهي (إفراز زيتي، مزيج من الأحماض الدهنية و} ساق الشعرة. Sebum is fairly antibacterial and consists mainly of lipids. ^{الأملاح) التي تفرغ في عمود الشعر ضايق انتشار كيرج. الزهم هو إلى حد ما مضاد للبكتيريا ويتكون أساسا من الدهون.}
- Sebaceous glands are found in all areas of the skin except the palms and soles. They are more numerous and larger on the face, scalp, chest, and neck. ^{توجد الغدد الدهنية في جميع مناطق الجلد ما عدا راحة اليد و} ^{النعال. إنها أكثر عددا وأكبر حجما على الوجه وفروة الرأس والصدر و}
- The acidic nature of sebum helps destroy harmful organisms on the skin, thus preventing infection. When ductules of the sebaceous glands become blocked, acne may result. Congested sebum causes formation of pimples or whiteheads. If the sebum is dark, it forms blackheads. Sex hormones, particularly androgens, regulate production and secretion of sebum. During adolescence, secretions increase; as the person ages, secretions diminish. ^{الطبيعة الحمضية للزهم تساعد على التخلص من الكائنات الضارة على الجلد. مما يمنع العدوى. عندما تصبح القنوات الصغيرة للغدد الدهنية مسدود، قد يؤدي ذلك إلى حب الشباب. الزهم المسد يسبب تكون البثور أو الرؤوس البيضاء. إذا كان الزهم داكنا، فإنه يشكل الرؤوس السوداء. هرمونات الجنس، خصوصا الأندروجينات، تتحكم في إنتاج وإفراز الزهم. خلال} ^{في فترة المراهقة، تزداد الإفرازات؛ ومع تقدم الشخص في العمر، تقل الإفرازات.} ^{فقدان الزهم، الذي يزيث البشرة، قد يكون أحد الأسباب} ^{تكون التجاعيد الذي يصاحب الشيخوخة. الغدد الدهنية هي} ^{يتواجد في جميع أنحاء الجسم ما عدا باطن القدمين وكفوف اليدين} ^{اليدين. إنها شائعة بشكل خاص على فروة الرأس والوجه، حول مثل هذه} ^{المفتحات مثل الأنف والفم والأذن الخارجية والشرج؛ وعلى الجزء العلوي من الظهر} ^{وكيس المصفن.}

Sweating Glands:

غدد العرق:

- 1- **Apocrine glands** are found in all areas of the skin except the palms and soles. They are more numerous and larger on the face, scalp, chest, and neck. These sweat glands secrete a milky substance that becomes aromatic when modified by skin surface bacteria.
الغدد الأبوكراين توجد في جميع مناطق الجلد ما عدا راحة اليدين وأصابع القدمين. إنها أكثر عدداً وأكبر حجماً على الوجه وفروة الرأس والصدر والرقبة. هذه الغدد العرقية تفرز مادة حليبية تصبح عطرية عند تعديلها بواسطة بكتيريا سطح الجلد.
- 2- **Eccrine glands** are widely distributed throughout the body, especially on the forehead, back, palms, and soles. One square of the skin contains about 3000 of these sweat glands. Sweat consists of salts, ammonia, urea, and other substances. These glands work to cool the body by evaporation, waste from pores, and moisturize the surface of skin cells.
الغدد الإكزينة منتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء الجسم، خاصة على راحة اليدين وأصابع القدمين. تحتوي قطعة واحدة من الجلد على حوالي 3000 من هذه الغدد العرقية. العرق يتكون من الأملاح، والأمونيا، اليوريا، و مواد أخرى. تعمل هذه الغدد على تبريد الجسم عن طريق التبخر، إزالة الفضلات من المسام وترطيب سطح خلايا الجلد.

➤ ملاحظات قبل فحص المريض: Notes before examining the skin:

1. Avoid focusing on the area identified by the patient, so that the whole organ needs to be examined.
1. تجنب التركيز على المنطقة التي حددها المريض، بحيث يحتاج العضو بأكمله للفحص.
2. After explaining the examination and asking permission, ask the patient to undress to their underwear and **lie back** comfortably on the exam table or bed, and cover them with a sheet.
2. بعد شرح الفحص وطلب الإذن، اطلب من المريض خلع ملابسه إلى ملابسه الداخلية واستلق بشكل مريح على طاولة الفحص أو السرير، وغطي نفسك إياهم بغطاء.
3. Ensure that the room is warm and private and that you have adequate lighting, preferably in the form of an adjustable light source.
3. تأكد من أن الغرفة دافئة وخاصة وأنك تملك إضاءة كافية، ويفضل أن يكون على شكل مصدر ضوء قابل للتعديل.

Assessment of skin status:

تقييم حالة الجلد:

- The bath is a perfect time.
الاستحمام وقت مثالي.
- Removal of Clothing, Jewelry, Cosmetics, Wigs, Hairpieces
خلع الملابس والمجوهرات والمستحضرات التجميلية والباروكات وقطع الشعر
- Prepare the environment (lighting, temperature, equipment, drapes, and privacy).
حضر البيئة (الإضاءة، درجة الحرارة، المعدات، الستائر، و الخصوصية)
- Positions used during nursing assessment, medical examinations, and during diagnostic procedures:
الوضعية المستخدمة أثناء تقييم التمريض والفحوصات الطبية وأثناء الإجراءات التشخيصية:
 - ✓ –Dorsal recumbent
وضع الاستلقاء على الظهر –
 - ✓ –Supine
الاستلقاء على الظهر –
 - ✓ –Sims
سيمز –
 - ✓ –Prone
الاستلقاء على البطن –
 - ✓ –Lithotomy
إجراء استئصال الحصى –
- Subjective data - Said by the client.
البيانات الذاتية - ما قصه العميل
- ✓ Like biographic data.
مثل البيانات البيوغرافية
- ✓ The chief complaint, source of the data.
الشكوى الرئيسية، مصدر البيانات

- ✓ **History of present illness, past medical history.**
تاريخ المرض الحالي، والتاريخ الطبي السابق.
- ✓ **Immunization history, allergies, habits.**
تاريخ التحصينات، التحسس، العادات.
- ✓ **Stressors, family history.**
العوامل المسببة للتوتر، التاريخ العائلي.
- **Objective data - Observed by the nurse**
البيانات الموضوعية - لاحظتها الممرضة
- **Explain when, where and why the assessment will take place**
اشرح متى وأين ولماذا سيجري التقييم
- **Help the client prepare (empty bladder, change clothes)**
مساعدة العميل على الاستعداد (تفريغ المثانة، تغيير الملابس)
- **Confirm the chief complain of the patient as well as the patient's health history.**
تأكيد الشكوى الرئيسية للمريض وكذلك صحة المريض التاريخ.
- **Healthy skin is smooth, connected, resisting pressure, with a full sense of moisture.**
البشرة الصحية ناعمة، ومتراصة، ومقاومة للضغط، مع إحساس كامل برطوبة.
- **The patient is asked whether he has suffered from trauma, a surgical operation, or a previous disease affecting the skin.**
يسأل المريض عما إذا كان قد تعرض لصدمة أو جراحة عملية جراحية، أو مرض سابق يؤثر على الجلد.
- **Is he suffers from chronic diseases such as diabetes.**
هل يعاني من أمراض مزمنة مثل السكري؟
- **Confirm the color of skin:**
أكد لون البشرة:
- ✓ **Pale means anemia or blood loss.**
باهت يعني فقر دم أو فقدان الدم.
- ✓ **Erythema means surface skin burns, topical inflammation, carbon poisoning.**
احمرار الجلد يعني حروق سطحية بالجلد، التهاب موضعي، كربون تسمم.
- ✓ **Pink means Fever, high blood pressure.**
الوردي يعني الحمى، ارتفاع ضغط الدم.
- ✓ **Purple means bruising in soft tissue.**
اللون البنفسجي يعني كدمات في الأنسجة الرخوة.
- ✓ **Yellow (Jaundice), Liver and kidney diseases, red blood cell breakdown.**
اصفر (يرقان)، أمراض الكبد والكلى، كريات الدم الحمراء انهيار.

Assessment Techniques to the skin:

تقنيات تقييم الجلد:

Penlight, Tongue depressor , Centimeter ruler مسطرة, Gloves

قلم ضوء، مكبس لسان، مسطرة سنتيمتر، هسطرة، قفازات

Magnifying glass مكبره , Flashlight , Wood's lamp.

عدسة مكبرة، مصباح يدوي، مصباح وود.

1. Inspection - critical observation:

1. الفحص - الملاحظة الدقيقة:

–Take time to “observe” with eyes, ears, nose

– خذ وقتك لـ «الملاحظة» بالعينين والأذنين والأنف

–Use good lighting

– استخدم إضاءة جيدة

–Look at color, shape, symmetry, position.

– انظر إلى اللون، الشكل، التناظر، الموضع.

–Odors from skin, breath, wound.

– روائح من الجلد، النفس، الجرح.

–Develop and use nursing instincts.

– طور واستخدم حدسك التمريضي.

General inspection of the skin:

الفحص العام للجلد:

1. Begin by scanning the whole surface of the skin for any abnormal lesions. This can be done in any order.
 1. ابدأ بفحص سطح الجلد بالكامل للبحث عن أي آفات غير طبيعية. هذا يمكن أن يتم في أي ترتيب.

2. Remember to inspect those areas that are usually **hidden** مخفية:
 2. تذكر أن تفحص تلك المناطق التي عادة ما تكون مخفية.

- Inner thighs
 الفخذين الداخليين
- Undersurfaces of female breasts
 الأسطح السفلية لثدي المرأة
- External genitalia
 الأعضاء التناسلية الخارجية
- Axilla
 الإبط
- Gluteal cleft (between the buttocks).
 شق الأرداف (بين المؤخرة).

3. Remember also to inspect the mucosal surfaces of the mouth, nails, hair, and scalp.
 3. تذكر أيضا فحص الأسطح المخاطية للفم والأظافر والشعر و فروة الرأس

Skin color:

لون البشرة:

Skin color varies widely between individuals but should always be even in distribution, with normal variation for sun-exposed surfaces.
 لون البشرة يختلف كثيرا بين الأشخاص ولكنه يجب أن يكون دائما متساويا في التوزيع، مع تفاوت طبيعي للأسطح المعرضة للشمس.

Inspecting a lesion:

تفقد الآفة:

Inspect each lesion carefully and note the following:
 افحص كل آفة بعناية وسجل ما يلي:

- ✓ Grouped or solitary? Pattern if grouped.
 تمط مجمع أو منفرد إذا كان مجمعا
- ✓ Distribution and location
 التوزيع والموقع

• Symmetrical or asymmetrical?
 • متماثل أم غير متماثل؟

• Peripheral? محيطي
 • محيطي؟ يذيطي

• In only light-exposed areas?
 • في المناطق المعرضة للضوء فقط؟

• Dermatomal? جلدي
 • جلدي؟

- ✓ Color
 لون
- ✓ Shape
 شكل
- ✓ Size
 الحجم
- ✓ Surface
 سطح
- ✓ Edge
 حافة
- ✓ Nature of the surrounding skin.
 طبيعة الجلد المحيط.

Note: When noting the distribution, bear in mind the type of clothing (or lack of) is usually at that site and what other objects or substances that part of the body would come into contact with. (Consider especially belt buckles الابزيم, watches, gloves, and jewelry).
 ملاحظة: عند تدوين التوزيع، ضع في اعتبارك نوع الملابس (أو عدم وجودها) عادة في ذلك الموقع وما الأشياء أو المواد الأخرى التي يكون عليها جزء من الجسم التواصل مع. (فكر بشكل خاص في أبازيم الأحزمة، الساعات، القفازات، و المجوهرات).

2. Palpation - light and deep touch:

2. التمس الخفيف والعميق:

- Gloves should be worn if there is bleeding or **exudate** present or if you are examining the genitalia.
- يجب ارتداء القفازات إذا كان هناك نزيف أو إفرازات موجودة أو إذا كنت فحص الأعضاء التناسلية.
- Back of hand to assess skin temperature.
- ظهر اليد لتقييم حرارة الجلد.
- Fingers to assess texture, moisture, areas of tenderness.
- الأصابع لتقييم الملمس والرطوبة ومناطق الحساسية.
- Assess size, shape, and consistency of lesions.
- تقييم حجم وشكل وثبات الآفات.

For each lesion, note the following:

لكل آفة، لاحظ التالي:

- Tenderness (watch the patient's face)
• الحساسية (راقب وجه المريض)
- Consistency
• التناسق
- Temperature; Use the back of your hand (inflamed lesions are usually hot)
• درجة الحرارة؛ استخدم ظهر يدك (عادة ما تكون الآفات الملتهبة ساخنة)
- Depth and height
• العمق والارتفاع
- Mobility;
• التنقل;
- What skin layer is the lesion in? Is it attached to any underlying or nearby structures?
- أي طبقة من الجلد يتواجد فيها المرض؟ هل هو متصل بأي طبقة تحتية أو الهياكل القريبة؟
- Can it be moved in all directions or only in one or two?
- هل يمكن تحريكه في جميع الاتجاهات أم فقط في اتجاه أو اثنين؟
- Does it move with movement of underlying muscle or tendons?
- هل يتحرك مع حركة العضلة أو الأوتار التي تحته؟

Beyond the lesion:

خلف الآفة:

The skin condition must be seen in the context of the whole patient, and other organ systems should be examined as necessary. Remember to palpate regional lymph nodes if appropriate.
يجب النظر إلى حالة الجلد في سياق المريض بالكامل، والأعضاء الأخرى يجب فحص الأنظمة حسب الحاجة. تذكر تدليك العقد اللمفاوية الإقليمية إذا كان مناسباً.

Some common skin color abnormalities

بعض مشاكل لون البشرة الشائعة

- **Jaundice**: a yellow tinge to the skin; best appreciated at sclera
• اليرقان: اصفرار في الجلد؛ يلاحظ بشكل أفضل في صلبة العين
- **Carotenemia**: a yellow-orange tinge to the skin that is similar to that of jaundice but the sclera are spared.
• كاروتينية: تصبغ أصفر برتقالي في الجلد يشبه يشبه ذلك اليرقان لكن الصلبة محمية.
- **Hemochromatosis**: slate-gray skin coloration
• داء ترسب الحديد (Hemochromatosis): تلون الجلد باللون الرمادي المزرق
- **Addison's disease**: darkened scars and skin creases on the palms and soles-also darkening of mucosa.
• مرض أديسون: ندوب قاتمة وثنيات الجلد على راحتي اليدين أخمص القدم – أيضا اسوداد الغشاء المخاطي.
- **Albinism**: a lack of pigmentation with white skin and pink irises
• البهق: نقص التصبغ مع بشرة بيضاء وقزحيات وردية
- **Vitiligo**: autoimmune phenomenon resulting in patchy loss of skin color
• البهق: ظاهرة مناعية ذاتية تؤدي إلى فقدان بقعي للجلد لون

3. Percussion - sounds produced by striking body surface

3. الطرق - الأصوات الناتجة عن ضرب سطح الجسم

–Produces different notes depending on underlying mass (dull, resonant, flat, tympani).
– ينتج نغمات مختلفة حسب الكتلة الأساسية (باهتة، صاخبة، مسطحة، طبولية).

–Used to determine size and shape of underlying structures by establishing their borders and indicates if tissue is air-filled, fluid-filled, or solid.
 – يستخدم لتحديد حجم وشكل البنى الأساسية عن طريق تحديد حدودها ويشير إذا كان النسيج ممتلئًا بالهواء، أو بالسوائل، أو صلبًا.

Descriptive terms for lesion shapes and patterns of grouped lesions:

مصطلحات وصفية لأشكال الآفات وأنماط الآفات المجموعة:

1. Linear خط مستقيم

1. خطي خط هسحقن

2. Annular على شكل حلقة

2. حلقي الشكل

3. Arciform على شكل قوس

3. على شكل قوس

4. Serpiginous حلزوني

4. متعرج حلزوني

5. Target نقطوي

5. الهدف قطبي

6. Gyrate تذبذبي

6. التدوير

Examinng a lump: كتلة مرتفعة عن الجلد

فحص كتلة: كخلت من جفعت عي الجلد

Any raised lesion or lump should be inspected and palpated as described

يجب فحص أي آفة أو كتلة مرتفعة ولمسها كما هو موصوف

previously. Note position, distribution, color, shape, size, surface, edge,

سابقا. لاحظ الموقع، التوزيع، اللون، الشكل، الحجم، السطح، الحافة،

nature of the surrounding skin, tenderness, consistency, temperature, and

طبيعة الجلد المحيط، الحساسية، القوام، درجة الحرارة، و

mobility.

When examining a lump, there are some points to pay particular attention

عند فحص كتلة، هناك بعض النقاط التي يجب الانتباه لها بشكل خاص

to.

إلى.

Which layer is the lump in?

في أي طبقة الورم؟

• Does it move with the skin? (epidermal or dermal)

• هل يتحرك مع الجلد؟ (سطحي أو جلدي)

• Does the skin move over the lump? (subcuticular)

• هل تتحرك البشرة فوق الورم؟ (تحت الجلد)

• Does it move with muscular contraction? (muscle/tendon)

• هل يتحرك مع انقباض العضلات؟ (العضلة/الأوتار)

• Does it move only in one direction? (tendon or nerve)

• هل يتحرك في اتجاه واحد فقط؟ (وتر أو عصب)

• If the lesion belongs to a nerve, the patient may feel pins and

needles in the distribution of the nerve when the lump is pressed.

إبر في توزيع العصب عند الضغط على الورم.

• Is it immobile? (bone)

• هل هو ثابت؟ (العظم)

Integument includes skin, hair, and nails:

يشتمل الغطاء الخارجي للجسم على الجلد والشعر والأظافر:

✓ Inspect: skin color and uniformity of color, moisture, hair pattern, rashes, lesions,

□ فحص: لون البشرة وتجانس اللون، الرطوبة، نمط الشعر، الطفح الجلدي، الآفات،

pallor, and edema.

شحوب وورم.

✓ Palpate: temperature, turgor تورم, lesions, and edema.

□ افحص باللمس: الحرارة، المرونة تنرو، الآفات، والوذمة

✓ Percussion and auscultation: rarely used on skin.

□ التحريك والسمع: نادرا ما يستخدمان على الجلد

✓ Hair – texture الملمس, distribution, scalp فروة الرأس, critters القمل (lice).

□ الشعر – الملمس، التوزيع، فروة الرأس، الحشرات (القمل).

✓ Nails - inspect and palpate

□ الأظافر - الفحص والملمس

✓ –Why palpate nails?

□ لماذا نفحص الأظافر؟ –

◆ –Cyanosis - is it true or not?

◆ –الزرقة - هل هي حقيقية أم لا؟

◆ - Delayed return of color indicates poor arterial circulation.

◆ - التأخر في عودة اللون يشير إلى ضعف الدورة الدموية الشريانية.

◆ Clubbing - loss of normal angle between nail and nail.

◆ chronic oxygen deprivation حرمان الأكسجين من الأكسجين دريا.

✓ Head - inspection and palpation

□ الرأس - الفحص والتلمس

– Size, shape, symmetry تناظر او تماثل

– الحجم، الشكل، التناسق تناظر أو تأتم.

1- Primary lesion :

الآفة الأولية ناقص واحد

A- Nonpalpable

أ- غير ملموس

✓ Macule البقعة

□ بقعة

✓ Patch

رقعة

B- Palpable

ب- ملموس

✓ Papule حطاطة

□ بقعة جلدية

✓ Plaque اللوحة

□ اللوحة اللحت

✓ Nodule عقدة

□ عقدة

✓ Tumor الورم

✓ Wheal الانتفاخ

□ وحل أو حكة بارزة على الجلد

C-FLUID-FILLED CAVITIES WITHIN THE SKIN

أكوام متائلة بمائل تحت الجلد

✓ Vesicle حويصلة

□ الحويصلة حصلت

✓ Bulla فقاعة

□ بولا فقاعات

✓ Pustule البثرة

□ البثرة

✓ Cyst الكيس

□ كيس الكض

3. Secondary lesions:

3. الآفات الثانوية:

A- Above the skin surface

أ- فوق سطح الجلد

• SCALES

الموازين

• ATROPHY ضمور

ضمور

• CRUSTS القشور

القشور

B-Below the skin surface

ب- تحت سطح الجلد

- FISSURE الشق

شق

- SCAR ندبة

ندبة

- EROSIONS

ندبة دتخ

- ULCERS قروح

التآكلات

- Excoriation-Keloid

القروح-الندبة الجدر

Vascular skin lesion:

الآفة الجلدية الوعائية:

1- Petechia الحبرة او النمش

Petechia هي نقاط حمراء صغيرة على الجلد

2- Ecchymosis نزف تحت الجلد

كدمة الجلفص اثنين

3- Purpura الفرورية

البرفرة الفرفرف ناقص ثلاثة

4- Hematoma ورم دموي

ورم دموي ناقص أربعة

5- Spider angioma ورم وعائي على شكل العنكبوت

ورم وعائي على شكل العنكبوت خمسة

6- Cherry angioma ورم وعائي على شكل الكرز

ورم انجيومي الكرز سالب ستة

7- Venous star

نجمة وريدية سبعة

Hair and nail symptoms:

Hair loss:

Alopecia is the loss of hair and should be treated in much the same way as any other symptom, noting the following:

- Mode of onset (sudden/gradual)
- Associated symptoms
- Pain
- Rash
- Family history of hair loss
- تاريخ العائلة في تساقط الشعر

Note also:

- Regions of hair loss (scalp, body, face)
- A recognizable pattern of hair loss?
- Male-pattern baldness is at the frontal and temporal areas of the scalp and at the crown.
- Hair loss at the very front of the scalp can be caused by pulling back of hair when styling, particularly in women.

Abnormal hair growth

Facial hair growth is common in post pubertal women, but many find this distressing. If the patient reports abnormal hair growth, treat as any other symptom but remember to ask about the following:

- FH of a similar problem
- Menstrual cycle—when was the last menstrual period? Are they usually regular or erratic?
- Symptoms of virilization (if female) e.g., voice change, clitoromegaly
- Prescription or OTC drug use or use of any supplements?

Important nail disorders and signs:

- **Splinter hemorrhages** are tiny, longitudinal streak hemorrhages under the nails caused by microemboli or trauma. They can be a normal finding in manual workers.
- **Pitting** involves tiny indentations on the surface of the nail. It is a feature of psoriasis and less commonly eczema, lichen planus, and alopecia area.
- **Leukonychia** is white discoloration of the nail. It is a sign of low albumin or chronic ill health.
- **Beau's lines** are transverse depressions in the nail. They coincide with arrested nail growth during a period of acute illness.
- **Koilonychia** nails like spoon shape (iron deficiencies anemia)
- **Clubbing**:
- **Onychomycosis** is fungal nail infection causing the nail to become thickened, opaque, and yellow. It often occurs with onycholysis and may be indistinguishable from psoriatic nail changes.

- **Anonychia:** complete absence of nails **الفقدان الكلي للأظافر**
Anonychia: الفقدان التام للأظافر
- **Platonychia:** flatting nails **تقوس الاظافر**
Platonychia: بلاتونيشيا: أظافر مسطحة
- **Racket nail:** flattened and expanded nails **أظافر تشبه مضرب التنس**
Racket nail: مضرب الخضض مسمار مضرب: مسامير مسطحة وواسعة
- **Onycholysis:** separation of nail form nail bed (thyrotoxicosis) **انفصال الظفر**
Onycholysis: انفصال الظفر: انفصال الظفر عن سريره (فرط نشاط الغدة الدرقية)
- **Melanonychia:** presence of brown color in nails plate **تصبغ الاظافر**
Melanonychia: ميلانويكيا: وجود اللون البني في صفيحة الظفر حصص الاظافر
- **Paronychia:** inflammation of tissue surrounding the nail **التهاب الانسجة**
Paronychia: التهاب حول الظفر: التهاب الأنسجة المحيطة بالظفر
المحيط بالظفر
الوضع بالضغط

Below are some skin lesions:

فيما يلي بعض آفات الجلد:

1. **Macule البقعة:** Are small changes in skin color flat top, different size and be less than 1 cm in diameter, such as (freckle النمش).
1. بقعة: هي تعبيرات صغيرة في لون الجلد، مسطحة القمة، بأحجام مختلفة و أقل من 1 سم في القطر، مثل (نشرة).
2. **Papules الحطاطة:** is palpable solid raised lesion, higher than the surface of the skin, and also smaller than 1 cm in the diameter of a solid texture ranging in size between the grain of chickpeas and lentils حبة.
2. الحطاطات: هي آفة صلبة مرتفعة يمكن لمسها، أعلى من سطح الجلد، وأيضاً أصغر من 1 سم في قطرها وله نسيج صلب يتراوح حجمها بين حبة الحمص دثج انص والعدس دثج انكيدش، مثل الثآليل (الثآليل) (الثآليل) (الثآليل).
3. **Wheal الانتفاخ:** They are swollen in an area and are filled with fluid and are usually temporary, such as for hives النحل.
3. الورم التفرار: هم منتفخون في منطقة ومليئون بالسائل و عادة ما تكون مؤقتة، مثل الشرى اندم.
4. **Vesicle الحويصلة:** A small, blister-like raised area of the skin that contains serous fluid, up to 1 cm. in diameter (e.g. poison ivy, اللبلاب السام, انهتالب انطاو).
4. حويصلة: منطقة صغيرة مرتفعة على الجلد تشبه البثرة وتحتوي على سائل مصللي، يصل قطره إلى 1 سم (مثل اللبلاب السام) (العقوب البسيط).
Shingles, chicken pox الماء, جدري الماء, Herpes simplex (يشبه الطفح الجلدي). الجدري المائي, chicken pox القوباء المنطقية
5. **Bulla الفقاعة:** A fluid-filled vesicle or blister larger than 1 cm. (e.g. burns, contact dermatitis).
5. البلوة الفقاعية: فقاعه مملوءة بالسائل أو بثرة أكبر من 1 سم. (مثل الحروق، التهاب الجلد التماسي).
6. **A plaque الوحة:** A patch or solid raised lesion on the skin or mucous membrane that is greater than 1 cm. in diameter (e.g. psoriasis).
6. الوحة: الصمغ أو صهتخ، آفة مرتفعة على الجلد أو الغشاء المخاطي الذي يزيد قطره عن 1 سم (على سبيل المثال الصدفية).
الحنث رقعة أو كتلة
7. **Nodule العقدة:** Solid elevated lesion that is larger and deeper than a papule (e.g. fibroma الورم الليفي, Baghdad boil).
7. العقدة: آفة صلبة مرتفعة أكبر وأعمق من الحطاطة (على سبيل المثال: الورم الليفي انيزو انهيفي، جدر البغدادي).
8. **Cyst كيس:** A closed sac or pouch which consists of semisolid, solid, or liquid material (e.g. sebaceous cyst كيس دهني).
8. كيس: كيس أو جيب مغلق يتكون من مادة شبه صلبة أو صلبة أو سائلة (مثل: كيس دهني).

9. Pustule البثرة: Small elevation of skin or vesicle or bulla that contains

9. Pustule البثرة: ارتفاع صغير في الجلد أو حويصلة أو فقاعة تحتوي على lymph or pus (e.g. impetigo القوباء, scabies الجرب, acne حب الشباب).
 (حب الشباب, الجرب انجرب, حب الشباب دة انتشابا) يستمتع بالنوم
 (اللمف أو القيح (مثل الحصف)

10. Petechiae النمش: They are smaller than 1 cm in diameter and are usually round-shaped from blood.

10. Petechiae النمش: إنها أصغر من 1 سم في القطر وعادة شكل دائري من الدم.

11. purpura الفرفرية: Purpura is a petechiae larger lobe than freckles.

11. purpura الفرفرية: البثرة هي بقع دموية أصغر من البثور (بوربوريا)

12. Ulcer القرحة: An open sore or lesion that extends to the dermis (e.g. pressure sores).

12. Ulcer القرحة: قرحة: جرح مفتوح أو آفة تمتد إلى الأدمة (مثل قروح الضغط).

13. Scar الندبة: A mark left in the skin due to fibrotic changes following healing of a wound or sore or surgical incision.

13. ندبة: علامة تترك على الجلد بسبب التغيرات الليفية التي تحدث بعد شفاء جرح أو قرحة أو عملية جراحية.

14. Fissures and Phagades الفطور والتشققات: A slit or crack like sore صدع مثل شق or crack like sore

14. الشقوق والفجوات: شق أو صدع يشبه القرحة that extends into dermis usually due to continuous inflammation and drying (e.g. athlete's foot, anal fissure).

15. Excoriation السحجة أو السلخ: It is a skin lesion caused by friction with a rough body.

15. Excoriation الانهزاز أو الانطذاج: هو آفة جلدية ناتجة عن الاحتكاك بـ جسم خشن.

16. Lichenification: Thickening and hardening of skin from continued irritation such as intense scratching looks like surface of mass.

16. التقرن الجلدي: سماكة وتصلب الجلد نتيجة الاستمرار التهيج مثل الحكمة الشديدة يبدو كأنه سطح الكتلة.



Papule—Up to 1.0 cm

حبة صغيرة — حتى 1.0 سم

Example: An elevated nevus

مثال: نتامة مرتفعة

الحطاطة Papule حبية

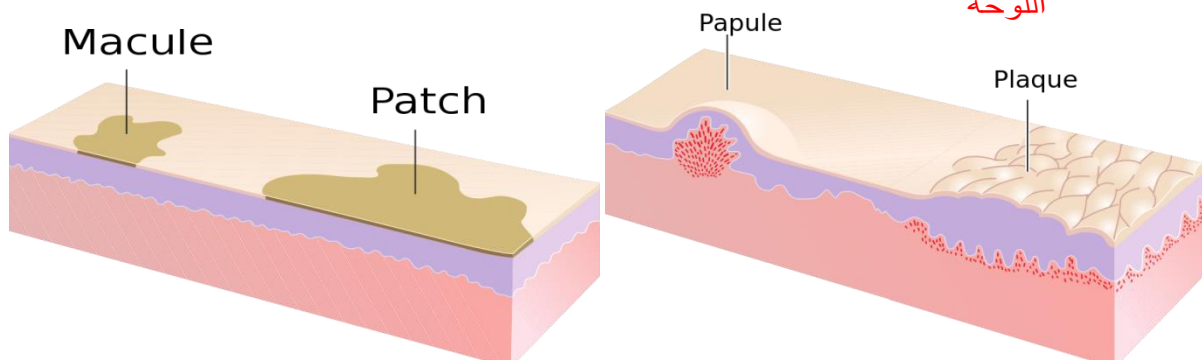


Fig. 3.1 Psoriasis. The plaque is well-defined, slightly raised and red. The silver scale is absent following treatment with a topical steroid and dithranol (anthralin).



Fig. 3.2 Psoriasis. Chronic plaques are covered by a silvery scale. The points of the elbows are characteristically involved.

Plaque الوحة





Endophytic nodule

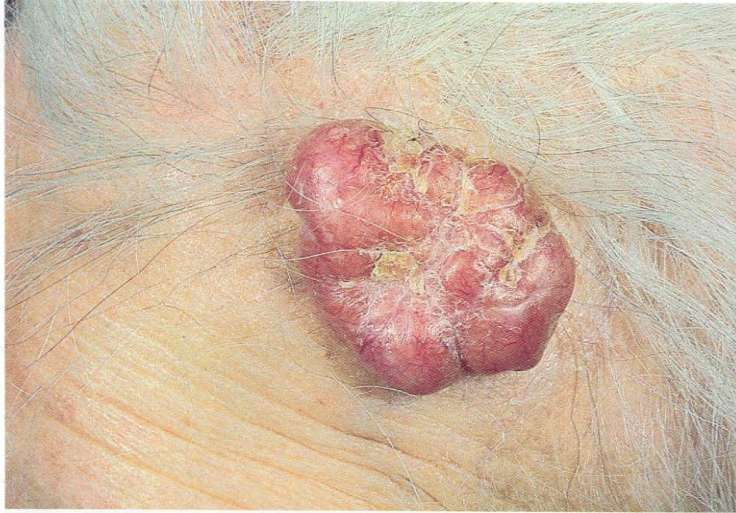


Fig. 6.65 Cylindroma. The scalp is a common site for this benign nodule. It has a smooth surface and telangiectasis may be present.

العقدة Nodule
عقدة



Patch—Flat spot, 1.0 cm or larger
بقعة — مكان مسطح، 1.0 سم أو أكبر

Example: Café-au-lait spot
مثال: بقعة كافيه-اولي



Macule—Small flat spot, up to 1.0 cm Examples: • Hemangioma • Vitiligo
بقعة — بقعة صغيرة مسطحة، حتى 1.0 سم أمثلة: • ورم وعائي • البهاق

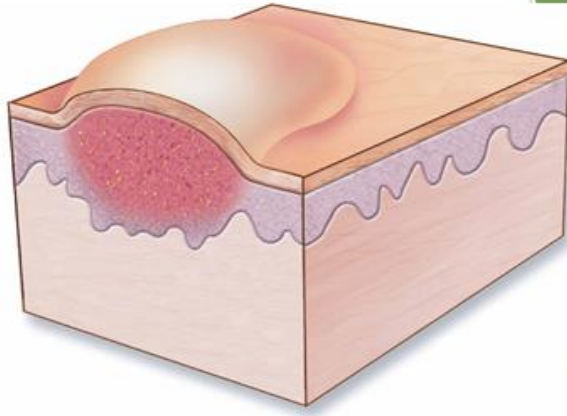


Vitiligo



Cyst کیس

Figure 11.42 Wheal.



الانتفاخ wheal
وذمة أو نتوء على الجلد

Figure 11.30 Hemangioma



Hemangioma ورم وعائي
ورم وعائي دموي

Figure 11.34 Petechiae.



Petechiae

نقط حمراء صغيرة



Ecchymosis

كدمة



البثرة Pustule
(Pustule) البثرة



Figure 11.29 Spoon nail.



Spoon nail
ظفر ملعقة



Bulla—1.0 cm or larger; filled with
فقاعة — 1.0 سم أو أكبر، ممتلئة بـ
serous fluid, Example: Insect bite
السائل المصلي، مثال: لسعة حشرة



Insect bite



Impetigo القوباء is a bacterial skin infection, is more common in children.
القوباء هو عدوى جلدية بكتيرية، وهو أكثر شيوعاً عند الأطفال.



Carotenemia

